

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新生兒腦室內出血 Neonatal Intra-ventricular Hemorrhage ; IVH				
編號	A31000-Q03-W-N08	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.6 版/7 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解新生兒腦室內出血的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部新生兒科單位。

三、說明

(一) 定義

因多重因素如低出生體重、氣胸、快速的體液擴張等導致新生兒腦室周圍的小血管（主要是微血管）破裂出血，本症是新生兒最常見的顱內出血，好發於早產兒，出生體重愈小的早產兒愈常見。臨床依出血範圍分為四個程度：第一度：腦室膜下出血，第二度：腦室內出血但無腦室擴張，第三度：腦室內出血且併有腦室擴張，第四度：腦室內出血且併有腦實質出血。第一度和第二度的出血通常可慢慢自動溶解而消失，有的在六個月後可在電腦斷層上看出腦間隙變寬；而第三度和第四度則易造成水腦。神經發展的後遺症在重度出血的存活病童中有 50-75%。

(二) 症狀

早產兒發生腦室內出血常是沒有症狀或常為非特異性症狀，如：呼吸暫停、頻繁的血氧降低、血壓下降、血色素降低、活力減低，臨床狀況急轉直下、抽筋等。

(三) 常見檢查

1. 腦部超音波(Brain echo)。

主題名稱	新生兒腦室內出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/7

2. 電腦斷層攝影(CT-scan)。

3. 核磁共振檢查(MRI)。

4. 腰椎穿刺之脊髓液檢查。

(四) 常見治療

1. 內科治療

(1)預防：避免早產、產前母體類固醇之使用、安胎藥物之使用、剖腹生產（較自然生產能減輕產道對早產兒頭部之擠壓）。

(2)支持性療法：以穩定生命徵象為主，並矯正有出血傾向之因子。之後需密集追蹤頭圍成長（每星期 2 公分以內），腦部超音波追蹤是否併發出血後水腦。

(3)藥物：抑制腦脊髓液產生之藥物如 acetazolamide，它屬於 carbonic anhydrase 抑制劑，為輔助性治療方式。

2. 外科治療

(1)出血後水腦的治療：反覆進行腰椎穿刺或腦室引流，以降低腦壓，每天每公斤可引流 10 cc，可減緩因水腦所造成之壓迫。

(2)體外腦室造口引流術(Extra-ventricular drainage；EVD)。

(3)腦室腹膜腔分流(V-P shunt)。

(五) 護理問題

1. 缺乏營養／少於身體需要／因疾病；食物攝取不足。

2. 易感染／第一道防線受損害／引流管留置。

3. 易受傷害／因疾病。

(六) 護理措施

1. 缺乏營養／因疾病

(1)每日以同一磅秤測量新生兒體重。

(2)監測實驗室檢查數據，並依醫囑補充輸液。

(3)觀察新生兒活力改變，密切監測生命徵象。

(4)與醫師討論餵食時間與餵食奶濃度。

主題名稱	新生兒腦室內出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/7

(5) 鼓勵病童母親餵母乳並教導母乳收集與保存方法。

(6) 開始餵食時採漸進式。

(7) 於母乳中加入母乳添加劑（一包母乳添加劑可提供 4kcal 及多種維生素與礦物質）。

(8) 餵食後抬高床頭 30 度，並採右側臥以幫助消化。

(9) 集中護理減少能量消耗以促進其生長。

2. 易感染／第一道防線受損害（侵入性治療或導管）

(1) 依醫囑測量體溫，監測生命徵象，觀察敗血症症狀。

(2) 每 1 小時檢視導管是否順暢，EVD 測量並紀錄顱內壓。

(3) 紀錄引流液之性質、量、色、味道，如有多量黏液或出血、惡臭和量太多時，需告知醫師。

(4) 每班評估導管周圍組織之情況並紀錄。

(5) 監測並追蹤實驗室檢查結果，依醫囑給予抗生素治療。

(6) 依醫師評估結果與病童需求，以無菌技術更換導管。

3. 易受傷害／因疾病

(1) 抬高頭部 15 度以降低顱內壓。

(2) 協助進行腰椎穿刺以降低顱內壓。

(3) 依醫囑給予維生素 K 或輸血。

(4) 每天測量頭圍並記錄。

(5) 監測 I/O 之平衡，避免顱內壓過高。

(6) 追蹤腦部超音波檢查結果。

(7) 抽痰時抽吸壓力低於 80 mmHg，動作輕柔。

(8) 微量接觸(minimal touch)：減少不必要之治療，以減少血壓之浮動。

(9) 避免快速輸液補充或高張容液輸注。

(10) 依醫囑矯正酸鹼不平衡問題。

(11) 如有需要可同步病嬰呼吸的呼吸器。

主題名稱	新生兒腦室內出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/7

(12) 追蹤腦部變化，觀察囟門是否膨出。

(七) 衛教指導

1. 新生兒腰椎穿刺檢查衛教（詳見護理部侵入性衛教單 E-Ped-020）。

2. 水腦行腦室腹膜腔分流術(V-P shunt)之衛教。

(1) 向父母解釋水腦的定義，腦室的解剖位置，及引流管存放的基本目的。

(2) 教導父母評估顱內壓升高、引流管阻塞及感染的症狀：觀察囟門的大小、有無膨出、壓力大或顱骨縫線分開的現象。

(3) 小於 2 歲的病童要每天測量頭圍並做記號以確保每日測量的位置相同。

(4) 定期門診追蹤注意是否有水腦復發的現象。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 陳月枝、黃靜微、林元淑、張綠怡、蔡綠蓉、林美華...魏琦芳(2021)・實用兒科護理學(9版)・台北市：華杏。

(二) 謝佳雲、林小絹(2021)・協助周腦室白質軟化症早產兒返家經驗・慈濟護理雜誌，20(2)，119-128。

(三) Paritosh Prasad,MD 原著、張佑全譯者(2022)神經學-新生兒加護病房・麻州總醫院兒科手冊(第3版)・台北：合記。

主題名稱	新生兒腦室內出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/7

七、附件

(略)

主題名稱	新生兒腦室內出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改及補充衛教內容	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.修正使用單位範圍 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	1.第三項第(六)目部份內容新增 2.增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	將參考文獻出處呈現於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.04.11	3.3	第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 04 月 11 日照護標準組會議通過； 108 年 05 月 15 日護理長會議通過； 108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	新生兒腦室內出血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	3.4	1. 修訂第三項第五、六目護理問題。 2. 更新第六項文獻參考資料。 3. 刪除內文參考文獻。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.5	1. 修訂第三項第六目之 1.(4)護理問題。 2. 更新第六項文獻參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.6	1. 修訂第三項第六目說明內容。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。